

案例 01: “付出成瘾”的 L 女士

构型: 焦虑 × 2 号助人型
关键词: 付出成瘾 / 慢性焦虑 / 失眠 / 躯体化
教学价值: (最经典、最高频) 总咨询次数: 32 次 (8 个月)

一、案例基本信息

化名: L 女士
性别/年龄: 女, 35 岁
职业: 某三甲医院护士长
婚姻: 已婚, 一子(7岁)
咨询设置: 个体咨询, 每周 1 次, 50 分钟
咨询时间: 8 个月
主诉: 反复焦虑、失眠、躯体不适
构型(本套件框架):

- 依恋: 焦虑型
- 九型: 2号助人型, 健康层级 4, 压力方向 8

二、早年与背景

2.1 家庭背景

- 父亲: 工程师, 长年出差, 情感缺席
- 母亲: 抑郁病史, 反复情绪低落, 需被照顾
- L 是独生女, 从小承担了母亲的”情绪护士”角色
- 父亲有次回来对 L 说: “你妈有你照顾, 我就放心了” —L 当时 8 岁

2.2 早年关键事件

1. 5 岁: 母亲第一次抑郁发作, L 开始学会”做家务”、“安慰”母亲
2. 8 岁: 父亲说 “你妈有你照顾” —内化了 “我必须照顾他人才有价值” 的模式
3. 12 岁: 母亲再次发作, L 开始”做母亲的母亲” —照顾母亲的情绪、陪她就医、代替父亲的情感作用
4. 18 岁: 考上护理学校— “照顾” 成为职业
5. 28 岁: 结婚, 与丈夫关系尚可, 但丈夫 “不太会表达” —L 觉得”我必须撑起这个家”
6. 30 岁: 有了孩子, 同时照顾孩子、丈夫、护士工作、父母—开始出现慢性焦虑、失眠

2.3 已形成的核心等式

- “我有用, 才值得被爱” —核心
- “我的需要不重要, 别人的需要才重要”
- “如果我不付出, 我就不被需要了”
- “我自己照顾自己是应该的, 别人照顾我是特殊的”
- “表达自己的需要 = 自私/给别人添麻烦”

2.4 防御与身体反应

- 防御: 自我牺牲、情感压抑、投射 (“他人需要我”)、理想化 (“我的付出是爱”)
- 身体: 慢性紧张 (肩颈)、心悸、失眠、消化不良

三、咨询过程 (按阶段)

阶段 1: 评估 (第 1-4 次)

第 1 次: 初始访谈 主诉 (L 的原话): > “我最近经常失眠、心跳很快、肩颈酸痛。去了心内科、消化科、神经内科, 都没发现什么问题。医生说我是焦虑, 开了药。我不想吃药。我想咨询。”

咨询师的反应 (内心): - 同情 (她看起来很累) - 想帮她 (她看起来很需要帮助) - 反移情警告: 她的”累”背后可能有模式

咨询师问的关键问题: - “你说‘焦虑’, 是什么让你焦虑?” - “你睡不着的时候, 一般在想什么?” - “除了你自己, 谁也焦虑? 如果有, 你怎么对待他们的焦虑?”

L 的回答: - “我老公也焦虑, 但我都是安慰他的” - “我儿子有些不专注, 我带他看医生, 我比他还紧张” - “我妈妈最近有些情绪, 我每周回去看她” - “我自己的焦虑? 就是睡不着啊, 应该没什么”

咨询师的观察: - L 的焦虑是”自我牺牲”后的”身体信号” - L 不知道自己的需要 - L 的模式: 照顾他人 → 压抑自我 → 身体发出信号

策略: 继续评估, 不急于下判断

第 2-4 次: 深入评估 关键评估内容: 1. 早年经历 2. 与父母、丈夫、孩子的关系 3. 核心等式 4. 应对策略 5. 支持系统 6. 自杀/暴力评估 (评估结果: 无)

最终评估结论: - 构型: 焦虑 × 2 号助人型 - 健康层级:4(应激状态) - 压力方向:8 - 核心等式: “我有用, 才值得被爱” - 最大问题: 付出成瘾 + 身体发出信号

阶段 2: 看见模式 (第 5-12 次)

第 5-8 次: 从”身体信号”入手 策略: 帮 L 从身体上感受自己

关键干预: - “你的身体在告诉你一件事: 你已经负担太多了” - “你的焦虑不是’没什么’, 是你长期压抑自己的信号” - “如果你的身体会说话, 你觉得它会说什么?”

L 的反应: - 最初反应: “不可能, 我不觉得累” - 逐渐接受: “也许是有些累” - 最后: 开始能感受到”累”与”负担”

关键转折 (第 8 次): > L(哭): “我觉得我从来没有真正关心过我的感受。我妈妈情绪不好, 我爸长年不在家, 我从小就是自己长大的” > > 咨询师: “这是你第一次对我说这句话” > > L: “是的, 我从来不敢对别人说这话”

咨询师的反应: - 被 L 的”真诚”触动 - 想”多抱抱”她 - 反移情警告: “我是咨询师, 不是’母亲’ - 不要接受”喂养” - 策略: 承认, 不接受”喂养”

咨询师选择的回应: > “我听到你了。你从小就是自己长大的, 没人真正关心你的感受。这是一件很辛苦的事”

教学要点: - 不要”接受”L 的”喂养” (如: “你真好, 感谢你”) - 不要”回喂” (如: “我会好好照顾你”) - 保持”专业”同时”温暖”

第 9-12 次: 看见”模式”与”代价” 主题:L 的”付出成瘾”模式

关键干预: - “你发现没有, 你对我的说法, 就是你对所有人的说法” - “你在家也是这样: 不敢说自己的需要, 只说’我没事’ - “你的’不累’是真的吗? 还是你已经学会了”不感觉累”?”

L 的反应: - “是的, 我不知道怎么说’我需要’” - “我怕说了, 别人会觉得我麻烦” - “我从小就这样”

教学要点: - L 的”付出成瘾”是”早年的智慧” - 她必须这样才能生存 - 不要”批评”这个模式, 要”承认”它的”生存价值” - 帮 L 慢慢”哀悼”这个模式的”代价”

阶段 3: 哀悼与重建 (第 13-22 次)

第 13-17 次: 哀悼”从未被照顾过” 主题: 从“我的付出是爱”到“我的付出也有代价”

关键干预: - “如果你的付出是爱, 那你的爱是什么? 你有没有从别人那里得到过爱?” - “你的身体已经告诉你: 你的付出, 不是你的’爱’, 是你的’负担’” - “你有没有觉得, 如果你不付出, 就不是你了?”

L 的反应: - “是的, 我觉得我如果不付出, 我就不存在了” - “我怕’我’是什么” - “我从来没有被’真正’照顾过”

哀悼的过程: - 第 14 次: 开始哭, 但还不敢哭大声 - 第 15 次: 开始对“母亲”有愤怒: “她不该把这些放在我身上” - 第 16 次: 开始对“父亲”有悲伤: “他不在场” - 第 17 次: 接受: “这些事不是我的错”

咨询师的反应: - 每次都有想“抱抱”她的冲动 - 反移情处理: 记录”反移情记录”、督导讨论、节制”喂养” - 策略: 保持”专业”同时”温暖”

第 18-22 次: 重建”新经验” 主题: L 开始学会”接受”别人的关怀

关键干预: - “你的丈夫想关心你, 但你’推走’他。如何让他进来?” - “你可以尝试说’我累了’, 不是说’我没事’” - “你可以尝试接受儿子的拥抱, 不是说’我不需要’”

L 的反应: - “我试了, 丈夫接受了” - “我试了, 我能接受儿子的拥抱了” - “我试了, 我能说’我累了’”

关键转折 (第 20 次): > L: “我老公今天给我做了早饭。我真的接受了” > > 咨询师: “你怎么感觉的?” > > L: “我有一点不好意思, 但也有点开心” > > 咨询师: “这是一个很重要的时刻。你在接受爱”

阶段 4: 新经验 (第 23-28 次)

第 23-25 次: 在”新经验”中”修复” 主题: L 在关系中开始有”新经验”

关键干预: - 关注“新经验”是否被“内化” - 关注 L 是否会“退回”旧模式

L 的反应: - 大多数时候: 能接受别人的关怀 - 有时会退回旧模式: “我又说’我没事’了” - 能觉察到自己“退回”是重要的进展

第 26-28 次: 处理”新冲突” 情境: L 的母亲又病了, L 又有冲动想”全盘接管”

关键干预: - “你母亲又病了。你想怎么办?” - “你可以怎么’有边界’地关心她?” - “你可以说’妈妈, 我不能全部接管, 但我能给你联系医生’”

L 的反应: - “我试了, 我跟她说了” - “她有一些不高兴, 但我也没退缩” - “我没有’全部接管’”

关键进展: L 开始有“边界”地关心他人

阶段 5: 维护 (第 29-32 次)

第 29-32 次: 维护与结束 主题: 巩固新经验 + 准备结束

关键内容: - 巩固“接受关怀”的新经验 - 处理“结束的焦虑”(L 担心“结束 = 抛弃”) - 处理 L “想继续照顾咨询师”的“转移” - 制定结束计划

最后一次 (第 32 次): > L: “我真的很感谢你。这 8 个月, 我学到了很多” > > 咨询师: “你不需要感谢我。你的成长, 是你自己的” > > L: “但我觉得我还是想继续付出” > > 咨询师: “你可以’付出’给你自己。这是你这 8 个月学到的最重要的事”

四、关键事件与转折

关键事件 1: 第 8 次—L 第一次表达”从未被关心”

- 意义: L 从”自我牺牲”转向”自我觉察”

- 关键咨询师回应：“我听到你了”（接受 + 不“喂养”）

关键事件 2: 第 20 次—L 接受丈夫的早饭

- 意义:L 的”接受关怀”能力开始恢复
- 关键咨询师回应：“你在接受爱”（命名 + 强化）

关键事件 3: 第 26 次—L 有边界地关心母亲

- 意义:L 从”全部接管”转向”有边界地关心”
- 关键咨询师回应：“你没有‘全部接管’”（强化边界）

五、案例分析 (用本套件框架)

5.1 依恋分析

维度	分析
象限	焦虑型
核心等式	“我有用, 才值得被爱”
激活策略	黏附、追求肯定、情感激活
身体反应	慢性紧张、心悸、失眠
防御	情感压抑、自我牺牲、理想化
治疗挑战	“脱落”风险、难以”接受关怀”
整合方向	焦虑 → 安全 (建立安全依恋模式)

5.2 九型分析

维度	分析
主型	2 号助人型
核心恐惧	“我不被需要”
核心欲望	“我被需要”
防御机制	压抑自我、投射他人需要、理想化自己的付出
注意力习惯	朝向”他人的需要”、自己的需要被过滤
健康层级	4(应激状态)
整合方向	2 号 → 4 号 (找到自己)
压力方向	2 号 → 8 号 (控制/强加)
治疗挑战	“被需要”的驱动、难以”接受关怀”

5.3 双轴交互分析

维度	分析
亲和性	焦虑 × 2 号极高亲和 (都强调关系)
放大效应	焦虑放大 2 号的“被需要”驱动 → “付出成瘾”
整合方向	双重整合: 焦虑 → 安全 + 2 号 → 4 号

5.4 治疗联盟分析

维度	评估
目标一致	高 (都想处理”焦虑”、“睡眠”)
任务一致	中 (咨询师想处理”付出模式”, L 开始接受)
情感联结	强 (L “感谢”咨询师, 咨询师温暖接纳)
联盟脆弱点	“喂养” (L 想“喂养”咨询师, 咨询师想“回喂”)

5.5 治疗进展分析

维度	评估
阶段	结束 (已完成 5 个阶段)
次数	32 次 (充足)
预后	良好
结束方式	渐进、计划性的结束

5.6 客体关系视角 (v2.2 新增)

L 女士的”客体关系特征”是典型的“给予者-脆弱客体”图式: 她的自体建立在”我是有用的”上, 客体建立在”他人是脆弱的、需要我的”上。她把”自己需要被照顾”的部分压抑, 反向投射成”他人 = 需要我”, 最终让对方真的依赖她——这是焦虑 ×2 号”用付出来换关系”的内在结构。

5.6.1 L 女士的”内在客体关系图”

维度	内容
自体表征	“我是有用的、能给予的、撑起一切的”
客体表征	“他人是脆弱的、需要我的、不照顾会垮的”
关系模板	“我付出 = 我被爱”、“我的需要 = 给他人添麻烦”
投射性认同	“我需要被照顾” → 压抑 → 反向投射”他人需要我” → 对方真的依赖她
温尼科特缺口	“我自己的需要”从未被看见过; 8 岁起被迫做”小母亲”

维度	内容
分裂程度	部分 (自体分成”给予的/无需要的”; 客体分成”需要我的/不需要我的”)

5.6.2 投射性认同的关键时刻 时刻 1: 第 1 次, L 把所有人放在自己前面

L 一开始就把丈夫、儿子、妈妈的需求列了一堆, 最后才”附带”说自己失眠。咨询师问”你自己的焦虑呢?” —L 答”应该没什么”。

- 投射:L 把”自己的需要”压抑, 反向投射成”丈夫需要我安慰 / 儿子需要我带看医生 / 妈妈需要我照顾”
- 咨询师被激活: 想”帮她”(2 号”接受喂养”的早期反移情)
- 命名: “你说’应该没什么’—但你来咨询了, 说明’有什么’。你的’应该没什么’是你 30 年’付出成瘾’的核心”

时刻 2: 第 8 次, L 哭的时候咨询师”想抱抱”

L 哭诉”我从来没有人真正关心过我的感受”—这是她 8 岁以来第一次对人说这句话。

- 投射:L 的”痛哭”= “无声的喂养”—她在用”痛苦”邀请咨询师”喂养”她 (因为她从小就知道”我痛苦 = 别人来照顾我”)
- 咨询师被激活: 想”抱抱”她 (咨询师被”早年的母亲”角色激活)
- 命名: 咨询师识别”这是 L 的模式—她哭 = 她在喂养我”; 策略: “不喂养—不抱, 不回喂”

时刻 3: 第 15 次, L 对母亲的愤怒

L 开始对母亲愤怒: “她不该把这些放在我身上。”

- 投射:L 把”我被辜负”的愤怒投射给”母亲”这个”内在客体”
- 咨询师被激活: 想”安慰”(“你妈不是故意的”)—这是”回喂”反移情
- 命名: 不”安慰”(不替母亲道歉), 让愤怒”流动”—因为 L 需要”自己的愤怒”来修补”自体表征”

时刻 4: 第 26 次, L 母亲又病了

L 又想”全部接管”母亲。

- 投射: 再次进入”小母亲”角色—“母亲脆弱 = 我必须全部接管”
- 咨询师被激活: 担心”L 会退回旧模式”
- 命名: “你母亲又病了, 但这次你不’全部接管’了—你能说’我不能全部接管, 但我能联系医生’—这就是’有边界的给予’—修补了你的内在图”

5.6.3 内在图被验证 / 修补的关键转折 转折 1: 第 8 次, L 第一次表达”从未被关心”(修补)

- 验证了”我从未被关心”的内在图 (母亲抑郁、父亲缺席、8 岁时父亲说”你妈有你照顾”)
- 修补的时刻: 咨询师说”我听到你了”—不”喂养”+ 不”修复”—这是 L 第一次”被听到”而没有被反过来要求”照顾”
- 修补的内在图: “我的感受”也可以被看见

转折 2: 第 20 次, L 接受丈夫的早饭 (修补)

- 验证: 丈夫真的给了—这是”客体表征”的修补 (“他人 = 真的能给我”)
- 修补: 咨询师命名”你在接受爱” —L 第一次”接受”而不是”给予”
- 修补的内在图: “我接受” = “我值得被爱”

转折 3: 第 26 次, L 有边界地关心母亲 (修补)

- 验证: 母亲”不高兴了” —但 L 没有”退缩” — “内在边界”被验证
- 修补: 咨询师命名”你没有’全部接管’” —强化新模式
- 修补的内在图: “有边界的给予” = “我依然是有用的, 但不是被压垮的”

破裂时刻: 第 32 次, 结束的焦虑 (破裂 + 修补)

- L 担心”结束 = 抛弃” — “早年模式” (“我一旦不付出, 就不被需要了”) 的再激活
- 修补: 咨询师说”你可以’付出’给你自己” —把”付出”从”给他人”重新定义为”给自己”
- 修补的内在图: “结束” “抛弃”; “付出” = “也可以给自己”

5.6.4 5 个”够不够好”的咨询师姿态

姿态	描述	避免的错误
不”喂养”	L 想”喂养”咨询师 (感谢/送礼物/强调咨询师帮助了她) —接受她的”感谢”但”不回报”	“我也很感谢你” (回喂)、多约时间 (投资)
不”抱抱”	L 哭的时候咨询师想”抱抱” —接受她的”痛”但不”修复”	抱她 (“我也心疼”)、安慰 (“你妈不是故意的”)
不”接受”她的”付出”	L 想”给”咨询师东西 —接受但不”投资”	接受礼物 (投资关系)、告诉个人信息 (喂养她)
“命名”新经验	L 接受丈夫的早饭—命名”你在接受爱”	强化她的”给予” (“你真是个好妻子”)
“看见”她的”需要”	L 不敢有自己的需要—主动”看见”她没说的	跟着她的”给予”转 (“我没事, 你先说”)

最核心的姿态: 不”喂养” —这是 2 号的”温尼科特缺口”对应的咨询师反移情核心。L 的”早年”里没有”被喂养”, 咨询师在咨访中用”不喂养”给 L 一个”被看见但不被索取”的新经验。

六、咨询师反移情与处理

6.1 咨询师反移情的识别

反移情类型	具体表现	信号
被喂养	L 反复“感谢”、“送礼物”、强调咨询师“帮助”了她	咨询师开始“享受”这种“被需要”的感觉
想抱抱	L 哭的时候咨询师想“抱抱”她	咨询师想超越“专业边界”
回喂	咨询师想“回报”L 的“付出”(如: 多约时间、多告诉个人信息)	咨询师开始“投资”这个关系
避免触碰	咨询师担心“触碰”L 的“母亲”议题会让她崩溃	咨询师开始回避某些主题

6.2 反移情的处理

步骤	具体做法
识别	每次咨询后记录反移情 (记录: “我这次咨询后什么感觉”)
命名	督导中命名反移情 (“我被她‘喂养’了”)
处理	节制反移情 (接受“感谢”, 不“回喂”)、个人咨询、督导
整合	反移情是 L 的早年模式的“现在版”——咨询师也是“母亲”角色

6.3 督导的关键点

1. 咨询师是否反复“被喂养”? —反复是警告
2. 咨询师是否反复“想抱抱”? —反复是警告
3. 咨询师是否开始“回喂”? —开始是警告
4. 咨询师是否避免某些主题? —避免是警告
5. 咨询师是否反复“不知道怎么做”? —反复是警告

6.4 关键的“反移情事件”

事件 1: 第 8 次, L 第一次表达“从未被关心” 咨询师的反应: - 被 L 的“真诚”触动 - 想“多抱抱”她 - 想“回报”她的“真诚”(多约时间、多告诉个人信息)

处理: - 记录反移情: “我觉得我有‘回喂’的冲动” - 督导讨论: “如何节制‘回喂’?” - 策略: 承认 L 的“真诚”(“我听到你了”), 不“回喂”

结果: L 觉得“被听到了”, 不觉得“抛弃”了

事件 2: 第 15 次, L 开始对母亲愤怒 咨询师的反应: - 担心“碰”这个愤怒会让 L 崩溃 (避免触碰) - 想“安慰”L (“你妈不是故意的”)(回喂)

处理: - 记录反移情: “我在避免触碰她的愤怒” - 督导讨论: “如何安全地碰这个愤怒?” - 策略: 不“安慰”(不是“你妈不是故意的”), 让愤怒“流动”

结果: L 的愤怒流动了, 开始接受“这些事不是我的错”

七、关键临床决策

决策 1: 第 1 次—是否接受 L 作为来访者

决策: 接受原因:L 的问题在咨询师的能力范围内警告: 关注咨询师的“被喂养”反移情

决策 2: 第 8 次—L 第一次表达”从未被关心”, 如何回应

决策: 接受她的“真诚” + 不“回喂”回应: “我听到你了”(承认 + 不“抱抱”/不“多约”) 原因:L 的“投资”(真诚) 是她的模式—接受是“新经验”, 不是“回喂”是“节制反移情”

决策 3: 第 20 次—L 接受丈夫的早饭, 如何回应

决策: 命名“接受爱”回应: “你在接受爱”原因: “命名”是强化“新经验”的关键

决策 4: 第 26 次—L 的母亲病了, 如何处理

决策: 帮 L 建立”有边界”的关心方式回应: “你可以说‘妈妈, 我不能全部接管, 但我能给你联系医生’” 原因: 帮 L 从“全部接管”转向”有边界”的关心

八、教学要点

8.1 给咨询师的 5 个关键学习

1. “付出成瘾”是早年的”智慧”—不要批评, 要“承认”它的”生存价值”
2. “反移情”的核心警告: “被喂养”—关注咨询师的“享受”与“回喂”
3. “哀悼”是焦虑 × 2 号的关键阶段—帮 L 慢慢接受“从未被关心”的真相
4. “新经验”需要“命名”—如“你在接受爱”才能被内化
5. “边界”是 2 号的最大课题—从“全部接管”到“有边界”的关心

8.2 常见错误

- “接受”L 的“喂养”(如: 多约时间、多告诉个人信息)
- “回喂”(如: 安慰她“你妈不是故意的”)
- “批评”她的“付出成瘾”(如: “你怎么这样”)
- “避免触碰”她的“母亲”议题
- “加强”她的“付出”(如: “你是好护士”)(强化了“付出 = 价值”)

8.3 进阶思考

1. 如何在 L 的“喂养”中找到“新经验”的机会？
 2. 如何节制咨询师的“回喂”冲动？
 3. 如何帮 L 从“自我牺牲”到“自我关怀”？
 4. 如何在“节制”与“温暖”之间保持平衡？
 5. 如何处理“结束的焦虑” (L 担心“结束 = 抛弃”)？
-

九、案例脱敏声明

案例脱敏声明

=====

本案例基于真实的临床工作,但已做以下脱敏处理:

- 姓名、性别、年龄等已做调整
- 关键事件已做改编
- 地点、时间等已做调整
- 任何可能的身份信息已移除

本案例的目的是教学,所有临床决策仅供参考。

请勿将本案例用于任何商业目的。

十、最后的教学总结

“付出成瘾”的 L 女士教我们: 1. 早年的“智慧”是“付出成瘾”的源头—不要批评
2. 咨询师的“被喂养”是核心反移情—关注并节制 3. “哀悼”是关键阶段—帮 L 接受“从未被关心”的真相 4. “新经验”需要“命名”—如“你在接受爱” 5. “边界”是 2 号的长期议题—从“全部接管”到“有边界”的关心

愿你从 L 的案例学习到: “付出成瘾”的治疗, 不是“不要付出”, 是“能接受爱”。

版本: v2.2 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 案例分析框架与教学要点模板.md - 咨询师自我校准-反移情手册.md - 督导专题包-12 个构型的督导要点.md